

Modul

Dasar-dasar Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan



Disusun oleh:
Instruktur PUSAT PENDIDIKAN GEOMIGAS

1

Content

- Pendahuluan
- Materi Pertolongan Pertama
 1. Dasar-dasar P3K di tempat kerja
 2. Rantai Penyelamatan
 3. Bantuan Hidup Dasar (Resusitasi jantung paru)
 4. Luka dan perdarahan
 5. Luka bakar
 6. Syok & pingsan
 7. Keracunan
 8. Pencatatan dan pelaporan

2

Tujuan Pelatihan

- Menyebutkan prinsip Bantuan hidup dasar (BHD)
- Menerangkan pentingnya hubungan “Rantai Penyelamatan” dalam bantuan resusitasi
- Melakukan BHD (Resusitasi Jantung Paru & Bantuan Napas) dengan benar, saat diperlukan
- Melakukan pertolongan pertama pada penanganan korban kecelakaan dan sakit

3

Tugas & Tanggung Jawab Penolong Pertama

- Untuk menjaga korban dari kemungkinan bahaya
- Untuk menginformasikan kepada petugas medis mengenai kondisi korban
- Untuk memberikan pertolongan pertama pada korban yang mengalami sakit ataupun kecelakaan
- Untuk melakukan identifikasi awal terhadap korban, sehingga memudahkan petugas medis dalam memberikan pertolongan lanjutan

4

Standarisasi pelatihan

- **American Heart Association (AHA) 2010**

- European Resuscitation Council (ERC)
- Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC),
- Australian Resuscitation Council (ARC)
- Resuscitation Councils of Southern Africa (RCSA)
- Council of Latin America for Resuscitation (CLAR)

5

Materi 1

Dasar – dasar P3K di tempat kerja



6

DASAR HUKUM

Undang – undang No.1/1970 Keselamatan Kerja:

Pasal 3, ayat 1 huruf (e): Memberi pertolongan pada kecelakaan

Permenaker No: Per.15/MEN/VIII/2008

Pasal 1

Ayat 1: P3K di tempat kerja adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/atau orang lain yang berada ditempat kerja, yang mengalami sakit atau cidera di tempat kerja

7

Permenaker No: Per.15/MEN/VIII/2008

Pasal 1

Ayat 2: petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/ pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja

Pasal 2

Ayat 1: Kewajiban Pengurus (Perusahaan) menyediakan petugas P3K & Fasilitas p3k di tempat kerja

Ayat 2 : Pengurus (Perusahaan) wajib melaksanakan P3K di tempat kerja

8

Permenaker No: Per.15/MEN/VIII/2008

Pasal 4

petugas P3K dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja/Buruh dan atau orang lain yang mengalami sakit/ cidera

Pasal 6

Tugas petugas P3K

- a. Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja
- b. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
- c. Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan
- d. Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus

9

DASAR HUKUM.....

KEPMEN ESDM No: 1827/K.30/MEM/2018

- Lampiran III Keputusan menteri & Sumber daya Mineral Republik Indonesia:
Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan menyediakan petugas, fasilitas, dan peralatan serta mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

10

Prinsip Pertolongan Pertama

4P

1. **P**reserve / Mempertahankan hidup.
2. **P**rotect / Melindungi korban.
3. **P**revent / Mencegah kondisi semakin parah.
4. **P**romote / Mendorong pemulihan.

11

Mengenali Keadaan Darurat

- Suara yang tidak biasa.
✓ *Mobil berdenyit, Dentuman keras, orang mengerang.*
- Bau yang tidak biasa.
✓ *Bau bahan kimia, bau sesuatu terbakar.*
- Pemandangan yang tidak biasa.
✓ *Darah, Orang Sempoyongan.*
- Tanda-tanda & perilaku gejala yang tidak biasa.
✓ *Tidak sadar, tidak bernafas, tidak ada nadi, Memar, Demam, Ruam, Muntah.*

12

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Perusahaan harus memastikan:

- Mereka menyediakan lingkungan kerja yang aman.
- Mereka menyediakan peralatan kerja yang aman.
- Pelatihan yang tepat disediakan.
- Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai.

13

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Karyawan harus :

- Melakukan kepedulian yang wajar untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain di tempat kerja.
- Melaporkan bahaya di tempat kerja.
- Mengikuti prosedur kerja.
- Mengenakan APD yang disediakan.

14

Kesadaran Karyawan

- Lokasi kotak dan ruang first aid.
- Nama, lokasi kerja, dan nomor kontak dari first aiders.
- Prosedur yang harus diikuti ketika pertolongan pertama diperlukan.
- Tindakan pencegahan standar untuk pengendalian infeksi.

15

Bagaimana cara memanggil bantuan

- Jumlah korban.
- Kondisi korban.
- Lokasi kejadian
- Potensi bahaya.
- Nama & nomor telepon.
- Jangan menutup telpon sampai diperintahkan untuk melakukannya oleh operator

16

Materi 2

RANTAI PENYELAMATAN



17

“Chain of survival / Rantai Penyelamatan”



1. Panggil Bantuan
2. Bantuan Hidup Dasar (BHD)
3. Defibrilator
4. Bantuan Hidup Lanjutan (BHL)
5. Fase Perawatan

18

1. Panggil Bantuan

Kapan harus meminta bantuan?

1. Saat pertama kali anda mengenali masalah gawat darurat
2. Pada kasus serangan jantung
3. Saat menemukan korban yang tidak sadarkan diri



19

2. BHD ---- Resusitasi Jantung Paru (RJP)

"Semakin Cepat Semakin Baik"

"Resusitasi Jantung Paru" (RJP) dilakukan segera setelah diketahui Korban tidak Sadarkan diri dan tidak ada napas.

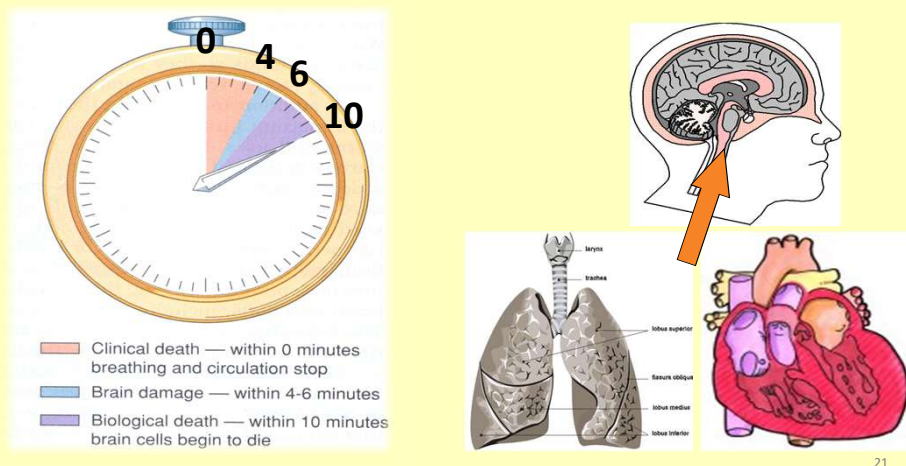
RJP dini sangat membantu pada kasus serangan Jantung



20

“Golden Period”

“Aliran darah yang penuh oksigen harus mencapai otak segera”



3. Defibrilasi Dini

Cara Kerja AED “Menghentikan Jantung Sesaat”



Cara Menggunakan AED:

1. Nyalakan AED
2. Tempelkan PAD pada dada korban
3. Ikuti Instruksi AED
4. Tekan tombol “Shock” saat AED menginstruksikan untuk memberikan shock

Catatan:

1. Pastikan dada korban kering sebelum menempelkan PAD
2. Saat AED menginstruksikan untuk memberikan Shock, pastikan semua orang di sekeliling korban tidak menyentuh korban, atau instruksikan “**STAND CLEAR**”
3. Jangan gunakan AED pada kendaraan yang sedang bergerak

22

4. Bantuan Hidup Lanjutan



Tim medis akan memberikan bantuan medis sesuai dengan kondisi korban

23

5. Fase Perawatan



Korban akan diberikan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan yang sesuai.

24

Materi 3

BANTUAN HIDUP DASAR



25



Pelaksanaan BHD (bantuan hidup dasar)

Kenali kejadian

Segera minta bantuan

Lakukan urutan tindakan pertolongan BHD

D - R - C - A - B



26

D_{-R-C-A-B} (DANGER)

Kondisi Bahaya Meliputi bahaya untuk:

- Diri sendiri
- Orang Lain
- Korban

DETEKSI KONDISI BAHAYA DENGAN

Penglihatan

Pendengaran

Penciuman



**JANGAN MENJADI
KORBAN
BERIKUTNYA !!**

27

D-R_{-C-A-B} (RESPON)

Periksa apakah korban berespon atau tidak – sadar atau tidak

- Panggil nama korban
- Tepuk bahunya
- Berikan rangsangan nyeri



28

D-R-C-A-B (RESPON)



JIKA KORBAN TIDAK ADA RESPON

**Teriak minta tolong/ Aktifkan
system emergency**

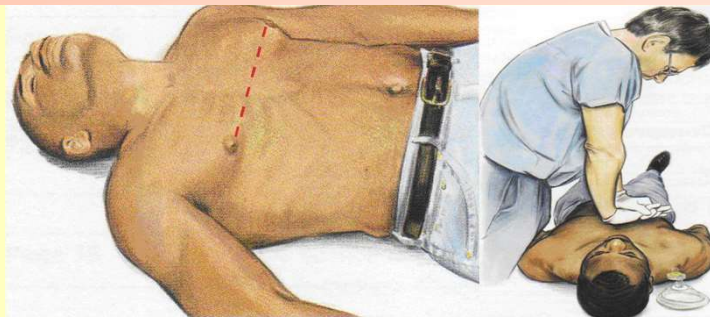


TOLONG!
Ada korban
tidak sadar!!

29

D-R-C-A-B (CIRCULATION)

Segera Lakukan "RJP/ CPR"
" 30 : 2 "



TITIK TEKAN :

**"Pertengahan Dada" Letakkan kedua tangan Anda pada
sternum setinggi garis antara papilla mammae.**

30

D-R-**C**-A-B (CIRCULATION)



- Posisi penolong - tegak lurus terhadap korban
- Kedalaman tekan - 5 cm
- Pada saat tidak menekan dada, jangan merubah posisi penekanan
- Kecepatan penekanan – 100x/menit

Berikan 30 kali penekanan dada

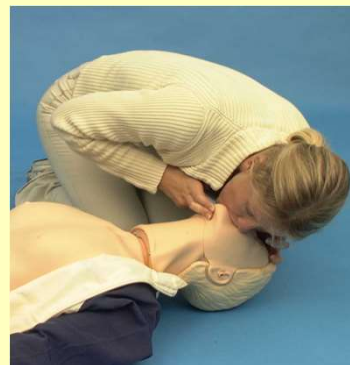
31

D-R-**C**-A-B (CIRCULATION)

Rasio RJP/CPR 30 : 2



**Tekan kuat, tekan cepat
30 x (100 kompresi/menit)**



Berikan Napas Bantuan 2x

32

D-R-C-**A**-B (Airway)

Setelah 30 x penekanan dada, Buka jalan napas

- Buka jalan napas korban " Head Tilt Chin Lift"
- Bersihkan jalan napas
- Pertahankan jalan **napas terbuka**

Head Tilt Chin Lift



33

D-R-C-A-**B** (BREATHING)

Berikan 2 X napas bantuan dari mulut ke mulut



1. Buka jalan napas korban
2. Pencet hidung korban, dan tutup seluruh mulut korban dengan mulut anda
3. Berikan 2 kali napas dengan tiupan napas **normal** dan jeda 1 detik setiap napas.

34

Berhenti melakukan RJP/CPR

JANGAN PERNAH BERHENTI MELAKUKAN RJP/CPR

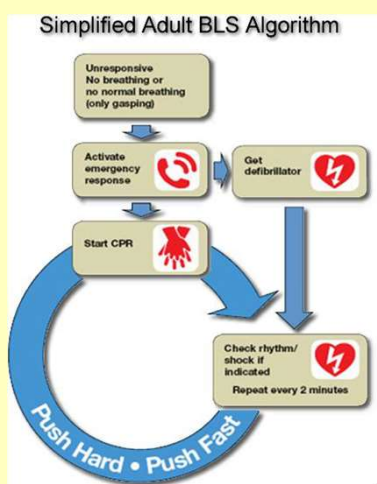
K.E.C.U.A.L.I

1. Korban sudah menunjukkan tanda tanda kehidupan
2. Petugas Medis tiba dan mengambil alih
3. Penolong kelelahan
4. Jika korban dinyatakan meninggal oleh dokter.
5. Jika ada bahaya lain yang mengancam korban dan penolong (misal: gempa atau kebakaran)



35

OVERVIEW (D-R-C-A-B)



Periksalah bahaya (D)

↓ No danger

Periksa respon korban (R)

↓ No response

Periksa Tanda Sirkulasi dan lakukan penekanan dada 30 x (C)

↓

Buka Jalan Napas (A)

↓

Berikan 2 x Napas buatan (B)

36

Recovery Position (Posisi Miring)

Tujuan posisi miring

- Mempertahankan jalan napas tetap terbuka
- Mencegah terjadinya aspirasi (masuknya muntahan ke jalan napas)

37

Cara membuat posisi miring



38

PRINSIP PENTING

1. Penolong Pertama adalah orang yang sangat diharapkan dapat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menyelamatkan jiwa KORBAN. Maka diperlukan tenaga yang terampil dan mampu menguasai diri untuk tidak PANIK dan mampu menjalankan prosedur tanggap darurat yang benar sesuai dengan RANTAI KESELAMATAN.
2. Dalam Rantai Keselamatan, pada saat memberikan bantuan hidup dasar, apapun KASUS KECELAKAANNYA, perlu untuk menerapkan Prinsip D-R-C-A-B
3. Keselamatan PENOLONG dan ORANG LAIN adalah Prioritas. Bantulah korban setelah DANGER CLEAR (Lingkungan dipastikan AMAN untuk memberikan pertolongan.

39

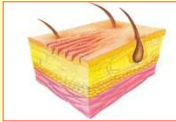
Materi 4

LUKA & PERDARAHAN

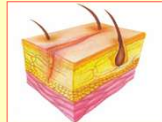


40

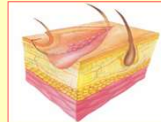
Klasifikasi Luka



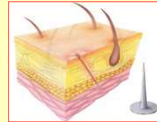
**Luka
Abrasi**



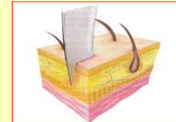
**Luka
Laserasi/
Luka Gores**



**Luka Avulsi /
Luka Robek**



**Luka
Tusuk**



**Luka
Menancap**

41

Contoh Luka Menancap



42

Klasifikasi Perdarahan

Perdarahan Arteri

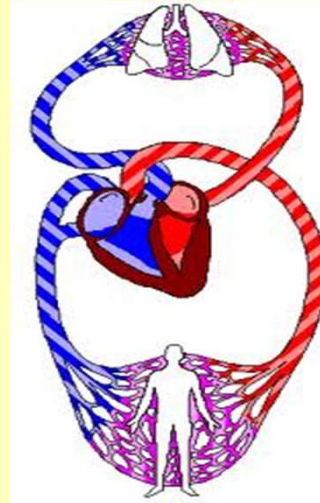
- Umumnya kaya oksigen
- Berwarna Merah terang
- Memancar dari luka

Perdarahan Vena

- Umumnya membawa CO₂
- Warna merah kehitaman
- Mengalir

Perdarahan Kapiler

- Merembes
- Pertama sekali mungkin agak lambat
- Perdarahannya umumnya tidak membahayakan



43

Prinsip Penanganan Perdarahan Luar



- Lindungi diri sendiri dengan menggunakan sarung tangan, bila memungkinkan
- Segera baringkan korban bila dia mengalami perdarahan hebat
- Segera lepaskan pakaian yang menutupi luka dan periksa apakah ada benda yang menempel

44

Prinsip Penanganan Perdarahan Luar



Tujuan:

- Mengontrol perdarahan
- Mengurangi kemungkinan terjadinya syok
- Mengurangi resiko infeksi
- Segera cari pertolongan medis

45

Prinsip Penanganan Perdarahan Luar

1. Tekan langsung / *Direct pressure*
2. Balutan Tekan / *Pressure roller bandages*

Catatan:

Berdasarkan AHA 2010, teknik elevasi dan pressure point tidak digunakan lagi karena terbukti kurang efektif untuk mengurangi perdarahan.



46

Prinsip Penanganan Perdarahan Luar

- Tetap jaga posisi si korban dengan istirahat dan kurangi rasa cemas
- Jangan diberi makan atau minum jika korban tidak sadar penuh



47

Prinsip Penanganan Amputasi



48

Prinsip Penanganan Perdarahan Dalam

- Posisi korban - istirahat dan kurangi rasa cemas
- Berikan kompres es pada bagian yang memar
- Jangan diberi makan atau minum jika korban mengalami penurunan kesadaran



49

Contoh Luka dan Perdarahan



50

Materi 5

LUKA BAKAR (Burn)



51

Penyebab Luka Bakar

- SUMBER PANAS (panas basah / panas kering)
- BAHAN KIMIA
- LISTRIK
- RADIASI
- SENGATAN DINGIN

Chemical burn



Dry Heat burn



Electrical Burn



Moist heat burn

52

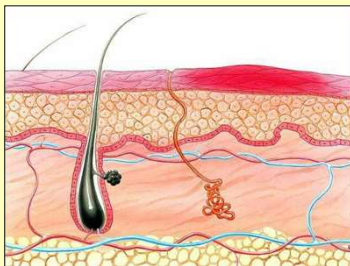
Pengkajian Luka Bakar

KEDALAMAN / DERAJAT LUKA BAKAR

LUAS / PERSENTASE LUKA BAKAR

53

Luka Bakar Derajat Satu



TANDA GEJALA

- Kemerahan
- Sakit

54

Luka Bakar Derajat Dua

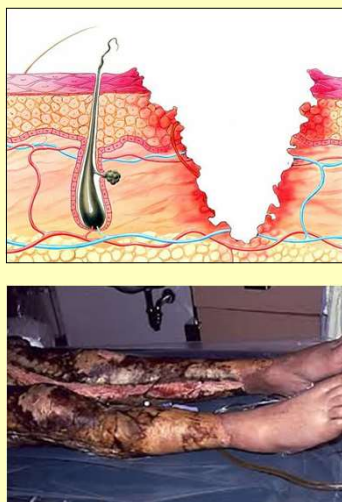


TANDA GEJALA

- Sangat sakit
- Kulit kemerahan dan membengkak
- Munculnya Blister/gelembung air

55

Luka Bakar Derajat Tiga

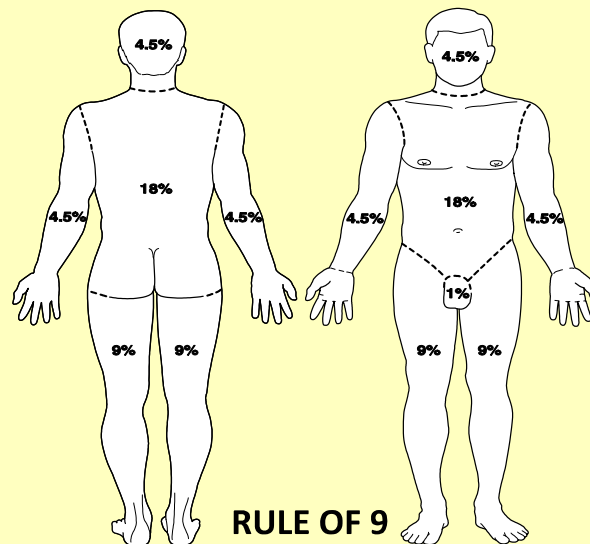


TANDA GEJALA

- Tidak sakit
- Kulit tampak kering
- Gosong, putih

56

Luas/Persentase Luka Bakar



57

Pentingnya Informasi Luka Bakar

Informasi Luas dan kedalaman LUKA BAKAR sangat penting untuk:

- Menentukan apakah korban dalam keadaan berbahaya/terancam nyawa atau tidak
- Menentukan tindakan medis selanjutnya

58

Luka Bakar Kritis

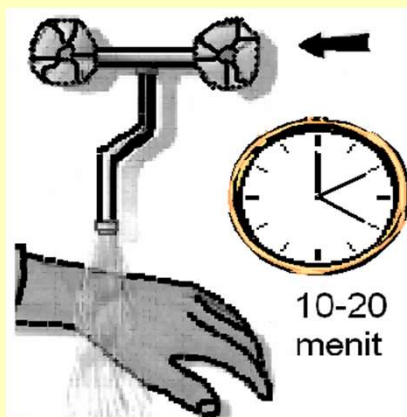
- Luka bakar 1^o > 75%
- Luka bakar 2^o > 20%
- Luka bakar 3^o > 10%

Luka bakar lainnya yang kritis namun areanya kecil:

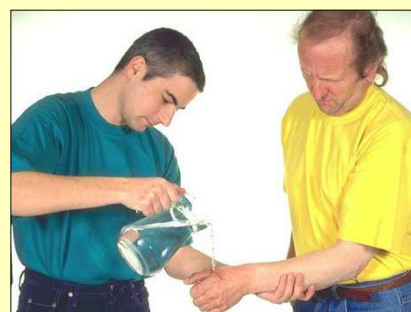
- Luka bakar pada telapak tangan dan kaki
- Luka bakar pada ketiak, selangkangan, dan alat kelamin
- Luka bakar pada dada, wajah yang mungkin juga membakar jalan napas dan paru-paru.
- Luka bakar listrik
- Luka bakar pada anak-anak/bayi.

59

Penanganan Luka Bakar



- PENDINGINAN SEGERA



60

Materi 6

SYOK & PINGSAN (Shock & Syncope)



61

Syok vs Pingsan

	Syok	Pingsan
Pengertian	Kondisi mengancam jiwa ketika tubuh kekurangan suplai darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh	Hilangnya kesadaran dalam waktu singkat, disebabkan oleh penurunan aliran darah ke otak yang bersifat sementara
Penyebab	cidera dan penyakit Perdarahan hebat Luka bakar Muntah dan Diare Reaksi alergi yang hebat – syok anafilaktik Rasa sakit yang hebat – syok neurogenik Gagal Jantung – syok kardiogenik	Penurunan aliran darah ke otak

62

Syok vs Pingsan

	Syok	Pingsan
Gejala	1. Napas cepat dan dangkal 2. Nadi cepat 3. Gelisah 4. Sesak napas 5. Kulit kebiruan terutama bibir 6. Lemah dan pusing 7. Mual dan muntah 8. Mulai hilang kesadaran	1. Nadi lambat 2. Kulit pucat, dingin 3. Berkeringat
Penanganan	1. Tinggikan posisi kaki 2. Jika tidak sadar dan tidak bernafas lakukan RJP/CPR	



63

Penanganan Korban Jika Tidak Sadar

D – R – C – A – B

**JANGAN TINGGALKAN KORBAN TIDAK SADAR
TANPA PENGAWASAN**

**Tetap periksa napas sampai bantuan datang.
Tetap tenang dan terkendali.**

64

Materi 7

KERACUNAN



65

KERACUNAN

Zat / bahan di bagi menjadi:

1. Zat / bahan tidak berbahaya
2. Zat / bahan berbahaya (racun)

Menurut terjadinya Keracunan :

1. Mendadak / akut
2. Perlahan / kronis

66

Keracunan zat kimia bisa terjadi di :

- **RUMAH**, biasanya akut, karena :
 - Kecelakaan
 - Penyalahgunaan
 - Percobaan bunuh diri (sengaja)
 - Kriminal
- **INDUSTRI** biasanya kronis akibat terpapar zat kimia yang lama
- **LINGKUNGAN**

Ingat !!! :

Setiap zat kimia pada dasarnya bersifat racun, keracunan ditentukan oleh :

- Besarnya takaran /dosis
- Cara masuk

JIKA MENEMUI KASUS KERACUNAN

- Penting penilaian kesadaran & pernafasan
- Pastikan setiap bahan kimia yang dipergunakan memiliki dokumen SDS (safety data sheet)
- Mengambil bahan / zat kimia bersama tempatnya & bahan utk pemeriksaan laboratorium
- Hubungi Pusat Informasi Keracunan (Bila Tersedia) dan atau klinik/ Pusat pelayanan gawat darurat

CARA MASUK RACUN

1. Melalui sal. pencernaan
2. Melalui sal. pernafasan
3. Kontak / tercemar – penyerapan melalui kulit / mata
4. Melalui suntikan
5. Melalui Gigitan / sengatan binatang

69

Tindakan saat keracunan

TETAP GUNAKAN PRINSIP

D-R-C-A-B

- **D – DANGER**
- **R – RESPONSE**
- **C – CIRCULATION**
- **A – AIRWAY**
- **B - BREATHING**

70

LARANGAN tindakan merangsang muntah, bila racun bersifat:

- Caustik korosif (Soda keras, asam keras) → perforasi !!!
- Bahan minyak tanah, bensin, tinner → terhisap / aspirasi
- Kesadaran menurun
- Kejang
- Wanita hamil

71

TERHISAP RACUN

Contoh: Gas Karbon (Co)

Gejala

- Spt gejala umum : pusing, sakit kepala, lemah, kdg muntah
- Kedutan otot, kejang – otot rahang kaku
- Nadi penuh dan terasa di kening, TD tinggi
- Orang-orangan mata melebar
- Ngantuk smp coma
- Batuk-batuk
- Suara serak
- Nafas cepat & ngorok ; henti nafas
- Kulit kelabu dg bercak merah kebiruan , bibir biru, pucat atau merah muda

72

TERHISAP RACUN

Tindakan :

- Aman untuk penolong & Proteksi diri
- Segera jauhkan penderita dari sumber racun ke tempat aman
- Baringkan penderita, kepala lebih tinggi, kendorkan pakaian yg ketat
- A-B-C terlebih dulu
- Bantuan ambulans 118 untuk wilayah DKI/ Sesuai prosedur perusahaan utk beri oksigen konsentrasi tinggi

73

TINDAKAN UMUM PADA KERACUNAN

- Amankan diri sendiri dulu dan lingkungan.
- Review MSDS/LDKB (Lembar data Keselamatan Bahan).
- Jauhkan korban dari racun & posisi berbaring
- A-B-C (tergantung masuknya racun)
- Minta bantuan & hubungi pusat pelayanan gawat darurat/ emergency channel/ klinik → kejadian, lokasi, dll.
- Ambil sampel / catat nama zat / bahan racun dari wadah dengan benar & perkiraan jumlah racun.
- Amankan bahan muntahan / feces utk pemeriksaan laboratorium.

74

Materi 8

PENCATATAN dan PELAPORAN *Record and REPORTING*



75

Pentingnya pencatatan dan pelaporan

- Manusia mempunyai ingatan yang terbatas
- Aspek legalitas akan tindakan PPGD yang dilakukan
- Mengobservasi keadaan korban, apakah semakin baik atau semakin buruk
- Menolong petugas medis dalam melihat keadaan pasien sebelumnya

76

Point pencatatan dan pelaporan

HAL YANG HARUS DILAPORKAN KE TIM MEDIS

- Beritahukan secara ringkas, riwayat kejadian
- Jenis kecelakaan (tabrakan, serangan jantung, jatuh)
- Jumlah korban
- Keadaan masing masing korban
- Tindakan PPGD yang telah dilakukan

77

TERIMA KASIH
Semoga SUKSES untuk Kita semua

78